ENDOMETRIOSE PARIETALE CICATRICIELLE POST-CESARIENNE

A propos d'un cas au service de chirurgie viscérale du CHUSS

Keïta N., Sanou J.D.D., Yabre N., Belemlilga G.L.H, Zaré C., Somé D.A.

PLAN

- ❑INTRODUCTION
- ❑OBSERVATION
- ❑DISCUSSION
- ❑CONCLUSION

INTRODUCTION

- ❖Endométriose: implantation ectopique de l'épithélium endométrial
- ❖Femmes en période d'activité génitale: prévalence de 10% .
  - ✓Externe: plus souvent génitale,
  - ✓Extra-génitale: rare , encore plus sur paroi abdominale
- ❖Pathologie chronique: diagnostic souvent tardif
- ❖Nous rapportons un cas d'**endométriose cicatricielle post césarienne**, dans le service de chirurgie générale et viscérale.

OBSERVATION

- Patiente âgée de 29 ans, sans comorbidité
- Geste 1, Pare 1, un enfant vivant né /césarienne décembre 2014.
- Consulte en juillet 2024 pour:
  - une tuméfaction au niveau de la cicatrice de opératoire,
  - indolore au début, augmentant progressivement de taille et devenant douloureuse.

OBSERVATION

- **ANAMNÈSE**: caractère cataménial de la symptomatologie
  - Exacerbation des douleurs pendant les menstruations,
  - Augmentation du volume de la masse pendant les menstruations
- **EXAMEN PHYSIQUE**:
  - Masse oblongue noirâtre dans le lit de la cicatrice opératoire
  - De 6 cm de grand axe au niveau du segment 1/3 moyen de la cicatrice
  - Bien limitée, fixée, sensible, surface bosselée par 3 gros nodules noirâtres.
  - Touchers pelviens sans particularités.

Aspect de l’endométriose pariétale médiane sur une cicatrice de Pfannstiel

OBSERVATION

❖EXPLORATION PARACLINIQUE

- **Echographie** des parties molles:
  - lésion de 60 mm hétérogène hypoéchogène,
  - située en plein milieu de la cicatrice opératoire.
- **Tomodensitométrie**
  - Masse oblongue de 6 cm, adhérente au muscle grand droit
  - hypodense et mal limitée.

OBSERVATION

❖CONDUITE TENUE

- ➢Indication d’une exérèse chirurgicale / sous la rachianesthésie
- ✓Incision cutanée péricicatricielle respectant 3 mm de marge.
- ✓Exploration:
  - ○masse tissulaire incrustée =>
    - • m. pyramidal , m. grand droit jusqu’à l’aponévrose.

OBSERVATION

❖CONDUITE TENUE

- Geste chirurgical:
  - Exérèse large de la masse trans pariétale,
  - Emportant une partie du muscle grand droit et son aponévrose en regard de la lésion
  - Réparation de la déhiscence pariétale par une prothèse herniaire
  - Drainage aspiratif
- Pièce opératoire conditionnée pour l'examen anatomopathologique.

OBSERVATION

❖RESULTAT ANATOMOPATHOLOGIQUE

- **Macroscopie**: aspect fibré noirâtre, pesant 380 g et mesurant 8 x 8 x 6 cm.
- **Histologie**:
  - Tissu cutané tapissé en surface par un épithélium Malpighien kératinisant acanthosique par endroit.
  - Derme sous-jacent fibreux et comportant des foyers de chorion cytogène avec des **glandes de type endométriales**.
  - **Absence de malignité** dans les limites du prélèvement.

OBSERVATION

❖EVOLUTION

- Cicatrisation complète au bout de 30 jours
- Suites opératoires simples (recul de 10 mois).

DISCUSSION

- **L'endométriose de la cicatrice de césarienne**:
  - Iatrogène , implantation de l'épithélium endométrial dans la cicatrice
  - Moins de 0,4% de l´ensemble des endométrioses.
  - Diagnostic souvent tardif / méconnaissance de la pathologie.
  - Durée moyenne entre chirurgie et moment du diagnostic excède 6ans
  - Survient chez les femmes en âge de procréer avec un pic autour de 40 ans
- Notre patiente: **29 ans** ; cumulait **9 années** avant le diagnostic étiologique.

DISCUSSION

❑SUR LE PLAN CLINIQUE

❖Diagnostic positif est suspect:

- ✓ Masse pariétale cicatricielle douloureuse sous ou adjacent à la cicatrice
- ✓Caractère cataménial ou non de la symptomatologie
- ✓Elément important d'orientation mais non indispensable.
- ✓Lésions très superficielles : saignement cyclique de la lésion .

DISCUSSION

❑SUR LE PLAN CLINIQUE

- ❖ Principales localisations sont pelviennes,
  - ▪ en majorité plus de 80 % après une incision de Pfannenstiel
  - ▪ et une minorité suite à une incision médiane verticale.
- ❖Kambire et coll: chez une patiente porteuse de 2 cicatrices
  - ▪ cicatrice au point de Mac Burney (appendicectomie) indemne
  - ▪ cicatrice de Pfannenstiel (césarienne) porteuse d'endométriose

DISCUSSION

❑SUR LE PLAN CLINIQUE

- Deux études antérieures (BF): 13 cas d'endométriose pariétales:
  - ✓ Trois cas d'endométriose cicatricielle post césarienne
  - ✓ Autres indications opératoires:
    - o laparotomies (kyste ovarien, fibrome)
    - o Péritonite d'origine gynécologique

DISCUSSION

- La **physiopathologie** de l'endométriose pariétale
  - La théorie d'**implantation**: dissémination iatrogène des cellules endométriales / chirurgie abdominopelvienne.
  - Plusieurs facteurs de risque dans la genèse de l'endométriose :
    - Période d'activité gynécologique
    - Exposition prolongée aux œstrogènes
    - Intervalles inter génésiques prolongés
    - Cycles menstruels courts, règles abondantes et prolongées

DISCUSSION

❑SUR LE PLAN PARACLINIQUE

❖Images échographiques et scannographies des EC: peu spécifiques.

- Aspect kystique ou tissulaire.
- Dépend de l'imprégnation hormonale en fonction du cycle.

❖L'intérêt de la TDM: étude de l'envahissement en profondeur des lésions.

❖L'IRM : examen de choix => lésions endométriosiques profondes

Indiquant un traitement médical associé à la chirurgie.

DISCUSSION

- Confirmation du diagnostic: histologique
  - ✓Présence, sur pièces opératoires de glandes endométriales
- Traitement de référence des endométrioses pariétales:
  - ✓Exérèse chirurgicale large d'emblée
  - ✓Notre patiente : exérèse large avec recours à une prothèse herniaire.
- Prévention de l'endométriose cicatricielle : effet bénéfique / laparotomie
  - lavage de la cavité péritonéale entre l'hystérorraphie et l'aponévrorraphie
  - Changement de gants avant sa fermeture pariétale.

CONCLUSION

- ✓L’endométriose pariétale est rare
- ✓Localisation sur la cicatrice de césarienne est la plus fréquente.
- ✓Le diagnostic peut être difficile pour la première fois,
- ✓ Evoqué devant une tumeur pariétale douloureuse et cyclique sur cicatrice
- ✓L’exérèse chirurgicale large apporte une guérison et éviter les récidives.
- ✓La confirmation diagnostique est histologique.

MERCI POUR VOTRE ATTENTION